

Estación de trabajo para el cuidado neonatal – Dräger Babylog® VN500

Soporte ventilatorio en cabecera de paciente de ventilación universal al lado de la cama: cuando los médicos entran en la zona de cuidado neonatal, ellos necesitan acceso inmediato a la completa gama de funciones del soporte respiratorio. Las terapias no invasivas, invasivas y avanzadas son componentes clave para cumplir con las necesidades de estos delicados pacientes.



DATOS TÉCNICOS

Tipo de paciente	Pacientes neonatos y pediátricos
Ajustes de ventilación	
Modos de ventilación	Ventilación controlada por presión: – PC-CMV – PC-AC – PC-SIMV – PC-PSV – PC-APRV (opcional) – PC-HFO (opcional) – PC-MMV (opcional) Soporte de la respiración espontánea: – SPN-CPAP/PS – SPN-CPAP/VS (opcional) – SPN-PPS (opcional)
Ampliaciones	– Ventilación de apnea – Activador de flujo – Función de suspiro – Volumen garantizado (VG) (opcional) – Compensación automática del tubo (ATC) (opcional) – PC-APRV con activación automática (opcional) – HFO-Sigh (opcional) – Volumen HFO garantizado en HFO(HFO-VG) (opcional)
Procedimientos especiales	– Maniobra de aspiración succión – Inspiración manual/mantenida – Nebulización de medicamentos
Tipos de terapia	– Ventilación invasiva (tubo) – Ventilación no invasiva NIV – Terapia de O₂
Frecuencia de ventilación (RR)	de 0,5 a 150/min



**Babylog® VN500 con Infinity®
Medical Cockpit™ C500**

Tiempo inspiratorio (Ti)	Neonatos de 0,1 a 1,5 s Pediátricos de 0,1 a 3 s
Tiempo inspiratorio nspiratorio máximo para respiraciones cicladas por flujo (Timax)	Neonatos de 0,1 a 1,5 s Pediátricos de 0,1 a 4 s
Volumen tidal (VT) (opcional)	Neonatos de 0,002 a 0,1 l bajo BTPS ± 8% del valor establecido Pediátricos de 0,002 a 0,1 l bajo BTPS ± 5% del valor establecido
Volumen tidal para soporte de presión (VT) (opcional)	Neonatos de 0,002 a 0,1 l bajo BTPS ± 8% del valor establecido Pediátricos de 0,002 a 0,1 l bajo BTPS ± 5% del valor establecido
Estado de activación de la ventilación de apnea	Encendido, apagado
Estado de activación de la función	Encendido, apagado
Retorno automático de la ventilación de apnea	
Volumen tidal durante la ventilación de apnea (VTapn)	Neonatos de 0,002 a 0,1 l bajo BTPS ± 8% del valor establecido Pediátricos de 0,002 a 0,1 l bajo BTPS ± 5% del valor establecido
Frecuencia respiratoria durante la ventilación de apnea (RRapn)	de 2 a 150/min
Flujo inspiratorio (flujo)	de 2 a 30 l/min
Presión inspiratoria (Pinsp)	de 1 a 80 mbar (o hPa o cmH ₂ O)
Límite de presión inspiratoria (Pmax)	de 1 a 100 mbar (o hPa o cmH ₂ O)
PEEP / PEEP intermitente (intPEEP)	de 1 a 35 mbar (o hPa o cmH ₂ O)
Tiempo de alcance de la presión de soporte aumento para el soporte de presión (rampa)	Neonatos de 0 a 1,5 s Pediátricos de 0 a 2 s
Concentración de O ₂ (FiO ₂)	de 21 a 100 % vol.
Sensibilidad de activación (activador de flujo)	de 2 a 5 l/min
Ventilación de liberación de presión en las vías aéreas (PC-APRV) (opcional)	– Tiempo inspiratorio (Thigh) de 0,1 a 30 s – Tiempo espiratorio (Tlow) de 0,05 a 30 s – Tlow máx: de 0,05 a 30 s – Presión inspiratoria (PGH) de 1 a 80 mbar (o hPa o cmH₂O) – Presión espiratoria (Plow) de 0 a 35 mbar (o hPa o cmH₂O) – Criterio de finalización (flujo espiratorio Exp. Term) de 1 a 80%
Soporte de presión proporcional (SPN-PPS) (opcional)	Ayuda de flujo – Neonatos de 0 a 300 mbar/L/s (o hPa/L/s o cmH₂O/L/s) – Pediátricos de 0 a 100 mbar/L/s (o hPa/L/s o cmH₂O/L/s) Ayuda de volumen – Neonatos de 0 a 4000 mbar/L (o hPa/L o cmH₂O/L) corresponde a la compensación de compliancia: de 10000 a 0,5 mL/mbar (or mL/hPa o mL/cmH₂O) – Pacientes pediátricos de 0 a 1000 mbar/L (o hPa/L o cmH₂O/L) corresponde a la compensación de compliancia: de 10000 a 1 mL/mbar (o hPa/L o cmH₂O/L)
Compensación de tubo automática (ATC) (opcional)	Diámetro de tubo interior Ø tubo – Tubo endotraqueal ET Pediátricos de 2 a 8 mm (de 0,08 a 0,31 pulgadas) Neonatos de 2 a 5 mm (de 0,08 a 0,2 pulgadas) – Tubo de traqueotomía Trach. Pediátricos de 2,5 a 8 mm (de 0,1 a 0,31 pulgadas) Grado de compensación de 0 a 100%
Oscilación de alta frecuencia Alta Frecuencia Oscilatoria (HFO) (PC-HFO) (opcional)	– Presión media en las vías aéreas (MAPhf) de 5 a 50 mbar (o hPa o cmH₂O) – Frecuencia de oscilación (fhf) de 5 a 20 Hz – Relación I a E (I:Ehf) de 1:1 a 1:3 – Amplitud de la presión (Ampl hf) de 1 a 90 mbar (o hPa o cmH₂O) – Volumen tidal (VThf) de 0,2 a 40 mL – Presión de suspiro (Psigh) de 5 a 80 mbar (o hPa o cmH₂O) – Frecuencia respiratoria de suspiro (RRsigh) de 1 a 30/min – Tiempo de aumento de la presión de suspiro (rampa suspiro) Pediátricos de 0 a 2 s Neonatos de 0 a 1,5 s Tiempo inspiratorio de suspiro (Tisigh) de 0,1 a 3 s
Compensación de fuga	– Encendido / apagado – Encendido: corrección de volumen/flujo y adaptación del activador – Apagado: adaptación del activador
Terapia de O ₂	Flujo continuo (BTPS) de 2 a 50 L/min Concentración de O ₂ FiO ₂ 21 a 100 % vol.
Ajustes de la maniobra Suspiro	Presión de suspiro (ΔintPEEP) de 0 a 20 mbar (o hPa o cmH₂O) Intervalo de tiempo entre suspiros (intervalo suspiro) de 20 s a 180 min Número de ciclos para un suspiro (ciclos suspiro) de 1 a 20 exhalaciones

Ajustes de la maniobra	
Enriquecimiento de oxígeno para una maniobra de succión	La concentración de FiO ₂ actual se multiplica por un factor configurado ente 100 y 200%
Nebulización de medicamentos	Se pueden configurar factores individuales para pacientes pediátricos y neonatos durante 5, 10, 15, 30 minutos
Succión endotraqueal	
Detección de la desconexión	automático
Detección de la reconexión	automático
Enriquecimiento de oxígeno inicial	máx. 3 minutos de FiO ₂ aumentado (factor de 100 a 200% de FiO ₂ establecido)
Fase de succión activa	máx. 2 minutos
Enriquecimiento de oxígeno final	máx. 2 minutos de FiO ₂ aumentado (factor de 100 a 200% de FiO ₂ establecido)

Valores medidos visualizados

Medición de la presión en las vías aéreas	Presión meseta (Pplat) Presión espiratoria final positiva (PEEP) Presión inspiratoria pico (PIP) Presión media en las vías aéreas (Pmean) Presión mín. en las vías aéreas (Pmin) Nivel de presión inferior en APRV (Plow) Presión inspiratoria final para respiraciones mandatorias (EIP) Nivel de presión superior en APRV (Phigh) Amplitud de presión (pico a pico) en HFO (ΔPhf) Rango de -60 a 120 mbar (o hPa o cmH ₂ O)
Medición de flujo (proximal)	Volumen minuto total (VM) Volumen minuto mandatorio (VMmand) Volumen minuto espontáneo (VMespon) Rango de 0 a 99 l/min BTPS
Medición de volumen tidal	Volumen tidal (VT) Volumen tidal inspiratorio (sin compensación de fuga) de respiraciones mandatorias (VTimand) Volumen tidal espiratorio (sin compensación de fuga) de respiraciones mandatorias (VTemand) Volumen tidal inspiratorio (sin compensación de fuga) de respiraciones espontáneas (VTispon) Rango de 0 a 5500ml
Medición de la frecuencia respiratoria	Frecuencia respiratoria (RR) Frecuencia respiratoria mandatoria (RRmand) Frecuencia respiratoria espontánea (RRspon) Rango de 0 a 300/min
Medición de O ₂ (lado inspiratorio)	Concentración de O ₂ inspiratoria (FiO ₂) Rango de 18 a 100% vol
Medición de CO ₂ en flujo principal	Concentración de CO ₂ espiratoria final (etCO ₂) Rango de 0 a 100 mmHg (o de 0 a 13,2% vol. o de 0 a 13,3 kPa) Volumen interno de cubeta CO ₂ de 5 ml

Valores calculados visualizados

Volumen minuto de fuga (MVleak)	Rango de 0 a 99 l/min BTPS
Fuga	Rango de 0 a 100%
Compliancia (C)	Rango de 0 a 650 mL/mbar (o mL/hPa o mL/cmH ₂ O)
Resistencia (R)	Rango de 0 a 1000 mbar/(L/s) (o hPa/(L/s) o cmH ₂ O/(L/s))
Proporción espontánea del volumen minuto en porcentaje (%MVspon)	Rango de 0 a 100%
Visualización de curvas	Presión en vías aéreas (t) (Paw) de -30 a 100 mbar (o hPa o cmH ₂ O) Flujo (t) de -40 a 40 L/min Volumen (t) (V) de 2 a 300 mL CO ₂ (t) de 0 a 100 mmHg (o de 0 a 15% vol. o de 0 a 13 kPa)

Alarmas / Monitorización

Volumen minuto espiratorio (VM)	Alto / Bajo
Presión en vías aéreas (Paw)	Alto / Bajo
Concentración de O ₂ insp. (FiO ₂)	Alto / Bajo (automático)
Concentración de CO ₂ espiratoria final (etCO ₂)	Alto / Bajo
Frecuencia respiratoria (RR)	Alto
Monitorización de volumen (VT) (en VG o VS)	Bajo (automático)
Tiempo de alarma de apnea (Tapn)	de 5 a 60 segundos, apagado
Tiempo de retraso alarma de desconexión (Tdisconnect)	de 0 a 60 segundos

Datos de rendimiento

Principio de control	ciclado por tiempo, controlado por presión, flujo continuo
Flujo inspiratorio BTPS	máx. 30 L/min
Flujo base, neonatos	6 L/min
Flujo base, pediátricos	3 L/min

Datos de funcionamiento**Alimentación eléctrica de la red**

Conexión de red	de 100 V a 240 V, 50/60 Hz
Consumo actual	a 230 V máx. 1,1 A Unidad de ventilación con Medical Cockpit a 230 V máx. 1,6 A con GS500 a 100 V máx. 2,5 A Unidad de ventilación con Medical Cockpit a 100 V máx. 3,7 A con GS500
Consumo de energía	máx. 250 W Unidad de ventilación con Medical Cockpit máx. 370 W con GS500
en funcionamiento, sin carga de batería interna	aprox. 100 W Unidad de ventilación con Medical Cockpit aprox. 180 W con GS500

Suministro de gas

Presión de O ₂	de 2,7 a 6,0 bar (o de 270 a 600 kPa o de 39 a 87 psi)
Presión de aire	de 2,7 a 6,0 bar (o de 270 a 600 kPa o de 39 a 87 psi)

Especificaciones físicas**Dimensiones (Anch x Alt x Prof)**

Babylog VN500	360 mm x 347 mm x 424 mm
Infinity® C500	414 mm x 284 mm x 95 mm
Babylog VN500 e Infinity® C500 en carro carrito de transporte	577 mm x 1400 mm x 677 mm
GS500 (solo montaje en carro carrito de transporte)	291 mm x 218 mm x 381 mm

Peso

Babylog VN500	aprox. 16 kg
Infinity® C500	aprox. 7 kg
GS500	aprox. 10 kg
Babylog VN500 e Infinity® C500	aprox. 25 kg
Babylog VN500 e Infinity® C500 en carro carrito de transporte	aprox. 59 kg
Montaje:	
Marco de soporte	aprox. 1,65 kg
Adaptador para barra de 38 mm	aprox. 2,35 kg

Infinity® C500

Diagonal screen size 17"
Pantalla táctil en color TFT
Puertos de entrada / salida
– 3 conectores externos RS232 (9 pins)
– 4 puertos USB (en el panel posterior)
– 2 puertos USB (uno en cada panel lateral)
– 1 DVI para salida de vídeo digital
– 2 DVI (sin utilizar)
– 2 conectores Ethernet RJ 45

Infinity® y Babylog® son marcas registradas de Dräger.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Medical Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36-8300
Fax +54 11 48 36-8311
info-argentina@draeger.com

CHILE

Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
Tel +562 482-1000
Fax +562 482-1001
info.cl@draeger.com

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B# 13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881
Fax +57 1 63 58-826

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 40 72
Fax +52 55 52 61 41 32

Fabricante:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemania
El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical GmbH está certificado según el anexo II.3 de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 e ISO 13485.